

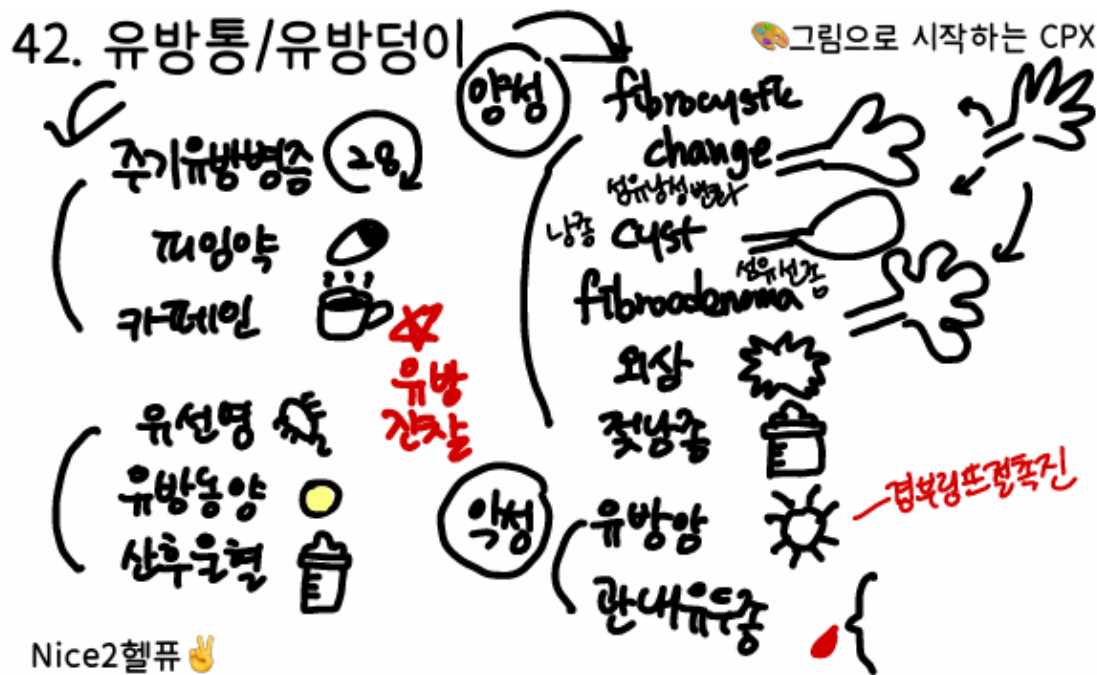
34. 유방통/유방덩이

• 중요 포인트

유방암에 대한 조기 진단 중요
월경 주기와의 관련성 확인

• Overview

문진 시작 시 비밀 보장 + 유방 진찰 시 반대쪽 가려주고 여성 간호사와 함께 진행 멘트
O~C 까지는 좀 차이, 뒤에는 동일
생리주기와의 연관성 확인 + 유방암의 위험인지 질문



• 평가 목표

원인		
유방통	호르몬 요인	생리주기, 약물 등
	기질적 요인	감염: 유방울혈 -> 유방염/유선염, -> 고름집/농양 (유방덩이) 비감염: 주기유방병증, 피임약/호르몬대체요법, 카페인에 의한 유방통, 유방 외상
유방덩이	정상	정상 유방, 섬유낭 변화
	양성 종양	유방낭종 / 섬유선종, 엽상종 / 관내유두종 / 젖농종
	악성 종양	유방암
	감염	고름집, 유방염 등
평가목표		
1) 유방통: 병력청취와 신체진찰로 유방통을 분류, 경과와 치료계획 수립		
2) 유방덩이: 병력청취와 신체진찰로 유방덩이의 특성/모양/성질 파악 -> 악성, 양성 구분하고 유방암 위험인자 파악, 필요한 진단과 기본적인 치료계획 수립		
구체적인 성과		
병력	유방 외 질환과의 감별	흉벽 통증: 가슴뼈 부위를 눌렀을 때 더 아픈지 (갈비연골염)

청취		연관통: 심장질환, 담낭질환, 폐렴 등의 주변 장기의 문제
	유방통의 특성 확인	주기성: 생리주기에 따른 통증이면 대개 정상 비주기성: 생리와 무관하게 한 곳 통증 시 유관확장증/유선염/종양 감별
	유방암의 위험인자 확인	가족력, 호르몬 노출(초경/폐경 시기, 출산/수유력, HRT/피임약)
	유방덩이의 성상 파악	어떻게 발견: 우연히/자가검진 변화 속도: 갑자기/서서히 유두 분비물: 혈성 - IDP/암
	생리 주기에 따른 변화 확인	생리 전 커졌다가 후 작아지면 섬유낭성 변화 등 양성 가능성 ↑
	유방암의 위험인자 확인	가족력, 호르몬 노출(초경/폐경 시기, 출산/수유력, HRT/피임약)
신체 진찰	압통의 부위 확인	어디가 아픈가요? 짚어보세요 -> 정확한 압통점 찾기 (ddx. 갈비연골염)
	유방덩이의 유무 확인	유방 전체 4 분면 체계적 촉진 통해 덩이 확인
	주변 림프절의 이상소견 확인	겨드랑이/쇄골 위 림프절 촉진
	유방의 정상 여부	정상: 대칭성, 피부에 함몰/Peau d'orange 소견 없음
	유방덩이의 유무 확인	4 분면 꼼꼼히 확인
	신체진찰 후 덩이의 특징 기술	위치/개수/모양/경계/딱딱/고정 등의 특징 파악
	악성 병변 의심 시 악성 병변의 진행 정도를 평가	림프절까지 종합해 진행 정도 파악 => 고정되어 있고 딱딱하면 악성 시사!
진단 및 치료	유방통	
	1. 확진 및 감별 진단을 위한 검사계획 수립 2. 통증 완화를 위한 치료계획 수립 => 악성 병변 배제 & 통증 유형 분류	
	유형 분류: 주기성/비주기성 영상검사: 유방촬영술, 유방 초음파	
	비약물적 치료: 생활습관 교정, 물리적 지지 약물적 치료: 국소 진통제, 호르몬 조절제	
유방덩이	1. 적절한 검사계획을 수립 2. 급성 조치가 필요한 경우를 감별하고 치료계획 수립 3. 수술이 필요한 환자 감별	
	임상 진찰 + 영상검사 + 조직검사	
	유방 농양 시 즉각적 절개 및 배농 + 항생제	
	수술: 악성 종양, 엽상 종양, 증상이 있는 양성 덩이	
환자 교육	유방통	생리 주기와의 관련성: 대부분 여성 H 변화에 의한 정상적인 반응 통증 완화를 위한 치료의 필요성: 일상생활에 지장있다면 약물 치료/스포츠브라 사용 고려
	유방덩이	자가 검진법 교육: 시기, 방법 설명 선별검사의 유용성 상담: 유방암은 일찍 발견할수록 높은 완치율. 위험인자 있을수록 꾸준히 시행
	PPI	불안 배려: 통증의 경우 암의 직접적인 신호는 아니기에 안심시키기 수치심 방지: 부분 노출(반대쪽 가리기), 검진 시 여성 간호사가 함께 있다고 말하기

• 원인 질환 정리

	질환	질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
유방통	감염					
	유방울혈	수유 초기에 젖이 과하게 차서 가슴이 팽팽하게 붓고 아픈 것	출산 3~5 일 후 빨강게 부어오름 전체적 통증, 열감	빨강게 부어오름, 단단/팽팽 양측성	유방초음파	아이스팩, 핫팩 마사지 진통제 규칙적으로 젓비우기
	유선염 (유방염) 0+1	유방 조직에 세균 감염으로 염증이 생김	출산 10 일 이후 모유수유, 한쪽유방 발열 및 국소적 통증 전신 증상	발적, 열감, 압통 보통 일측성 (국소적인 경결)	유방촬영술 유방초음파 혈액검사	수유 중단 X 더 자주 카페인 자제 아이스팩, 핫팩 마사지 진통제, 필요시 항생제
	유방농양 2+1	유선염이 진행되어 유방 조직 안에 고름이 생김	발열, 오한, 통증, 열감, 명울 스치기만 해도 아픔	발적, 압통 (파동이 느껴지는 국소 명울)	유방촬영술 유방초음파 혈액검사	바늘흡인 절개배농 항생제
	비감염/호르몬					
	유방외상	가슴 부위를 부딪히거나 다침. 안쪽 조직이 손상되었을 수도	유방 외상 병력	-	유방촬영술 유방초음파	수술, 항생제
	주기유방 병증	호르몬에 의한 정상적인 생리적 반응	월경 시작과 함께 양쪽 유방통, 다발성 덩이 - 섬유낭 변화 동반 가능	유방조직 두꺼움?	유방촬영술 유방초음파	카페인 자제 진통제 자가검진
	피임약/호 르몬대체 요법	복용중인 호르몬 약이 유방 조직을 자극하여 통증 유발	양쪽 유방 부풀어오름 폐경 이후 통증 X	-	유방촬영술 유방초음파	안심시키기 자가검진 약물 조절
	카페인에 의한 유방통	카페인에 호르몬 대사에 영향을 주어 가슴 통증을 예민하게 함	커피, 카페인 음료를 자주 마심	-	유방촬영술 유방초음파	카페인 자제 자가검진
유방 덩이	양성 종양					
	섬유낭 변화 2+2	생리주기에 따른 호르몬 변화로 유방 조직이 뭉치거나 작은 물혹이 생김.	30~40 대 월경주기에 따른 유방 통증, 결절	치밀하고 단단하게 만져지는 조직 주로 양측, 다수	유방촬영술 유방초음파	흡인 / 절제
	유방낭종 (섬유낭변 화 일부) 1+2	M/C 젖이 흐르는 길 일부가 막히면서 액체가 고여 물혹이 생긴 것	월경 직전까지 커지다가 월경 후 감소됨	물렁한 종괴	유방초음파 유방초음파 세침흡인	작 - 세침흡인 큼 - 절제 약(재발, 혈성) - 중심침
	"생리 전만 되면 가슴 전체가 붓고 울퉁불퉁해지면서 아파요" -> 섬유낭 변화 가능성 UP! "어느 날 갑자기 한 군데에 매끈한 구슬 같은 게 만져져요" -> 유방 낭종 가능성 UP!					
	섬유선종 3+1	유방의 유선 조직과 주위 조직이 과도하게 자라서 생긴 단단한 혹	20 대, 점점 커지는 딱딱하고 단일한 종괴 주기에 따른 변화 X	움직임 O 무통성 작은 크기 단단한 종괴	유방촬영술 유방초음파	경과관찰 크거나 빨리 자라면 절제생검
	엽상종	유방의 유선 조직과 주위 조직이 과도하게 자라서 생긴	40 대 빠르게 커지는 딱딱하고 단일한 종괴, 주기에 따른 변화 X	움직임 O 무통성 큰 종괴	유방촬영술 유방초음파	국소절제술

		단단한 혹				
	관내유두 종	젖이 흐르는 길 안에 생긴 작은 혹	단일 유두관 혈성 분비물	단일관 혈성 분비물 유륜 하부 주위 작은 종괴	유방촬영술 유방초음파 세침흡인	선택적 유관 절제술 유륜 주위 절개를 통한 전절제
	젖낭종	수유 중 젖이 나가는 길이 막혀 젖이 고여 덩어리처럼 만져짐	수유 중단 후 6~10 개월	움직임 O 등글고 경계 명확 유즙으로 찬 낭종	유방촬영술 유방초음파 세침흡인	세침흡인 재발 시 수술적 절제
	여성형 유방	호르몬 불균형 여성의 유방조직이 생김 간/신 질환 이노제	유륜 하방에 대칭적으로 smooth, firm mass 압통이 있다가 무통성		유방촬영술	안심 및 경과관찰 노인 - 기저질환 치료 수술
	악성 종양					
	유방암 4+1	유방 조직 내에서 비정상적인 세포가 자라남	한쪽유방	단단한 멍을 피부 함몰 오렌지 껍질 혈성 유두 분비물	유방촬영술 유방초음파 주변 림프절 검사	수술, 항암, 방사선

[유방덩이]

PPI	오늘 문진 내용은 의료 목적으로만 기록되며, 타인은 볼 수 없으니 걱정하지 마시고 편하게 말씀하시면 됩니다.						
O	언제부터 멍울이 생겼나요? 갑자기?						
L	멍울이 있는 부위가 어디인가요? 위치 짚어보세요 반대쪽은 괜찮나요? 단측(유방낭종) vs 양측(섬유낭병)						
D	멍울이 지속적으로 만져지나요? 월경 주기? r/o 섬유낭 변화						
Co	점점 더 크기가 커지나요? 개수는 많아지나요?						
Ex	이전에도 이런 적 있으셨나요? 치료?						
C	(덩이) 모양/개수/크기/경도/경계/이동/압통 몇 개인가요? 대략 몇 cm 크기인가요? 딱딱 or 물렁 고정 or 이동 통증/압통 -> NRS 몇점? -> PPI 유방통) 양상 주기에 따라 변하나요?						
A	open Q 전신) 발열/오한/피로/체중감소 유방) 발적/부종/열감 함몰(유방/유두), 굴껍질 같은 피부소견(Peau d' orange) 유두 분비물? 색깔/편측 or 양측 겨드랑이) 멍울/압통 <table><tr><td>피로, 체중감소 함몰, 굴껍질같은 피부 편측/혈성 분비물 겨드랑이 멍울</td><td>유방암</td></tr><tr><td>유방 열감/발적 겨드랑이 압통</td><td>울혈/유선염/농양 염증성 유방암</td></tr></table>			피로, 체중감소 함몰, 굴껍질같은 피부 편측/혈성 분비물 겨드랑이 멍울	유방암	유방 열감/발적 겨드랑이 압통	울혈/유선염/농양 염증성 유방암
피로, 체중감소 함몰, 굴껍질같은 피부 편측/혈성 분비물 겨드랑이 멍울	유방암						
유방 열감/발적 겨드랑이 압통	울혈/유선염/농양 염증성 유방암						
F(여)	open Q) 악화/완화 상황 월경주기에 따라 크기가 변하나요? 월경력: 규칙적/생리량/월경통/LMP + 임신가능성/피임방법(피임약) 산과력: 결혼/아이(만-조-유-생)/모유수유(지금도 하시나요?) 위험인자: 초경 나이, 첫 출산나이, 모유수유, 현재수유, 폐경 나이, 피임약/호르몬제						
E	마지막 건강검진? 유방진찰/산부인과 검진?						
외	가슴 쪽 부딪히거나 다친 적? r/o 유방 외상 수술 받았거나 유방 보형물 넣은 적?						
과	현재 앓고 계신 질환이 있나요? 기본: 고혈압/당뇨/고지혈증/결핵 여성: 유방/자궁/난소						
약	복용중인 약물? 피임약/호르몬제						
사	기본: 음주/흡연/커피(카페인)/식습관(고지방식이)/직업/스트레스						
가	비슷한 증상 암 가족력/자궁,난소,유방 질환력						
PEx	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 눈: 빈혈, 황달 2 입: 탈수					
	유방진찰	유방 노출에 대한 PPI 확실하게 하기!! 여성 간호사와 함께하며, 반대쪽 가려주기 1) 앉아서 시진 (유방) 먼저 눈으로 보겠습니다, 저를 따라서 먼저 팔 내리기 -> 양손 뒤통수 -> 손 허리 -> 앞으로 숙이기					



(겨드랑이) 팔을 올려주세요. (같은 손 팔로 들어올림)

2) 앉아서 촉진(반대쪽 2,3,4th 손가락 이용)

(림프절) 목에 있는 림프절 만져보겠습니다

(겨드랑이) 이제 한번 만져볼게요. (위에서부터 3 번에 걸쳐 촉진)

3) 누워서 유방진찰

다음으로는 유방진찰 시행하겠습니다. 누워주시기 바랍니다.

'오른쪽(정상인쪽)'부터 진행하겠습니다. '왼쪽'은 덮어드릴게요.

검사의 정확도를 높이기 위해 등에 수건을 잠시 받치겠습니다.

오른손은 이마 위, 어깨를 뒤 수건에 붙이고, 오른쪽 다리는 왼쪽 위로 올려 골반을 틀어주세요.



바깥쪽 먼저 진찰하겠습니다.

팔을 어깨 옆으로 내려주시고 이제 다리를 펴주세요.



안쪽 진찰하겠습니다.

+) 유두진찰(동의 구하기)

먼저 눌러보겠습니다. (한손 받치고 유두 한바퀴)

분비물 짜보겠습니다. (엄지 검지로 360 도)

이제 반대쪽 하겠습니다.



PPI	옷정리 도와주고 불편한 점 없었는지 확인		
검사, 치료	기본 검사	① 유방촬영술 ② 유방초음파 ③ 혈액검사: CBC, 혈중 PRL, 임신반응검사	
	Cystic lesion	섬유낭 변화 유방낭종 젖낭종	경과관찰, 흡인 흡인, 내부 고형 성분 보이면 중심침생검 흡인
	Solid mass -> 조직검사	섬유선종 엽상종 유방암	경과관찰, 절제 광범위 국소 절제 수술, 항암치료
	Nipple discharge	관내유두종 유방암	유관절제술 유방암 치료

	Inflammation	울혈 -> 유선염 -> 농양	냉/온찜질, 유축/수유 -> 소염제/항생제 -> 농양 시 배액
교육	지금 가장 걱정되는게 있으신가요? 공감/안심) 유방덩이가 유방암을 의미하는 것은 아닙니다. 추정진단) 지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 ~~가 의심됩니다. 기전설명) 해당 질환은 ~~ 질환으로 명물이 만져질 수 있습니다. 감별진단) 하지만 이 외에도 ~~등의 질환도 배제할 수 없어 추가적인 검사가 필요합니다. 치료) ~~를 통해 치료를 진행할 수 있습니다. <i>ex) 현재 만져지는 혹의 양상이 다소 딱딱하고 주변 조직과 유착된 느낌이 있습니다. 악성 종양(암)의 가능성을 염두에 두고 가장 먼저 정밀 검사를 진행해야 할 것 같습니다. 관내 유두종이나 염증 같은 양성 질환의 가능성도 있지만, 유방 질환에서 암은 절대 놓쳐서는 안 되는 질환이기 때문에, 이번 기회에 확실히 검사를 해서 안심하시는 것이 좋겠습니다</i> 안심) 모든 유방덩이가 유방암을 의미하는 것은 아닙니다. (암이 강력히 의심되는 경우 아니라면) 유방암은 초기에 발견할 경우 치료 성적이 좋기에 병원에 일찍 잘 오셨습니다. (암 의심되는 경우) 회피/교정) 지방이 많이 함유된 음식 줄이기 술/담배 끊기, 카페인 줄이기, 적절한 운동 엎드려 자지 않기 수유 전 등 유방 만지기 전 손 씻기 자가 검진법 교육) 시기:생리가 끝나고 2~7 일 뒤(가장 말랑할 때). 폐경 후라면 매달 일정한 날짜. 시진:거울 앞에서 양팔을 올리거나 허리에 얹고 피부 함몰, 유두 변화 확인. 촉진:손가락 마디(pads)를 이용해 원을 그리며 겨드랑이까지 꼼꼼히 문지름. 유두를 짜서 분비물이 나오는지 확인. 검사) ① 30 세 이후: 매달 월경 후 3~4 일 쯤 자가검진 ② 35 세 이후: 2 년 간격으로 의사에게 검진 ③ 40 세 이후: 2 년 간격으로 검진과 함께 유방촬영술, 자가검진 선별 검사 유용성) "유방암은 일찍 발견할수록 완치율이 매우 높습니다. 특히 가족력이 있거나 위험 인자가 있는 분들은 자가 검진뿐만 아니라 1~2 년마다 정기적으로 유방 촬영술을 받는 것이 가장 확실한 예방법입니다."		

[유방통]

PPI	오늘 문진 내용은 의료 목적으로만 기록되며, 타인은 볼 수 없으니 걱정하지 마시고 편하게 말씀하시면 됩니다.					
O	언제부터 아프셨나요? 갑자기/서서히?					
L	통증이 있는 부위가 어디인가요? 위치 짚어보세요 반대쪽은 괜찮나요? 통증이 이동하거나 주변으로 뻗어지는 않나요?					
D	한번 아프면 얼마나 지속? 하루에 몇번/얼마나 자주?					
Co	통증이 점점 심해지나요? 아팠다 안아팠다/계속?					
Ex	이전에도 이런 적 있으셨나요? 치료?					
C	open Q) 아픈게 정확히 어떤 느낌인지 말씀해주시겠어요? 양상 - 짓누르듯, 찢어지듯, 찌르듯 정도 - NRS 몇점? -> PPI 아픈곳에 멍울이 만져지기도 하시나요? -> (덩이) 모양/개수/크기/경도/경계/이동/압통					
A	open Q 전신) 발열/오한/피로/체중감소 유방) 발적/부종/열감 함몰(유방/유두), 굴껍질 같은 피부소견(Peau d' orange) 유두 분비물? 색깔/편측 or 양측 겨드랑이) 멍울/압통 <table><tr><td>피로, 체중감소 함몰, 굴껍질같은 피부 편측/혈성 분비물 겨드랑이 멍울</td><td>유방암</td></tr><tr><td>유방 열감/발적 겨드랑이 압통</td><td>울혈/유선염/농양 염증성 유방암</td></tr></table>		피로, 체중감소 함몰, 굴껍질같은 피부 편측/혈성 분비물 겨드랑이 멍울	유방암	유방 열감/발적 겨드랑이 압통	울혈/유선염/농양 염증성 유방암
피로, 체중감소 함몰, 굴껍질같은 피부 편측/혈성 분비물 겨드랑이 멍울	유방암					
유방 열감/발적 겨드랑이 압통	울혈/유선염/농양 염증성 유방암					
F(여)	open Q) 악화/완화 상황 월경주기에 따라 통증이 변하나요? 마사지, 아이스팩 사용 시 완화되나요? r/o 울혈/유선염 월경력: 규칙적/생리량/월경통/LMP + 임신가능성/피임방법(피임약) 산과력: 결혼/아이(만-조-유-생)/모유수유(지금도 하시나요?) 위험인자: 초경 나이, 첫 출산나이, 모유수유, 현재수유, 폐경 나이, 피임약/호르몬제					
E	마지막 건강검진? 유방진찰/산부인과 검진?					
외	가슴 쪽 부딪히거나 다친 적? r/o 유방 외상 수술 받았거나 유방 보형물 넣은 적?					
과	현재 앓고 계신 질환이 있나요? 기본: 고혈압/당뇨/고지혈증/결핵 여성: 유방/자궁/난소					
약	복용중인 약물? 진통제? 피임약/호르몬제					
사	기본: 음주/흡연/커피(카페인)/식습관(고지방식이)/직업/스트레스					
가	비슷한 증상 암 가족력/자궁,난소,유방 질환력					
PEx	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 3 눈: 빈혈, 황달 4 입: 탈수				
	유방진찰	유방 노출에 대한 PPI 확실하게 하기!! 여성 간호사와 함께하며, 반대쪽 가려주기 1) 앉아서 시진 (유방) 먼저 눈으로 보겠습니다, 저를 따라서 먼저 팔 내리기 -> 양손 뒤통수 -> 손 허리 -> 앞으로 숙이기				



(겨드랑이) 팔을 올려주세요. (같은 손 팔로 들어올림)

2) 앉아서 촉진 (반대쪽 2,3,4th 손가락 이용)

(겨드랑이) 이제 한번 만져볼게요. (위에서부터 3 번에 걸쳐 촉진)

(림프절) 목에 있는 림프절 만져보겠습니다

3) 누워서 유방진찰

다음으로는 유방진찰 시행하겠습니다. 누워주시기 바랍니다.

'오른쪽(정상인쪽)'부터 진행하겠습니다. '왼쪽'은 덮어드릴게요.

검사의 정확도를 높이기 위해 등에 수건을 잠시 받치겠습니다.

오른손은 이마 위, 어깨를 뒤 수건에 붙이고, 오른쪽 다리는 왼쪽 위로 올려 골반을 틀어주세요.



바깥쪽 먼저 진찰하겠습니다.

-> 양손 2,3,4 번째 손가락 끝으로 'ㄷ'자 모양으로 촉진
팔을 어깨 옆으로 내려주시고 이제 다리를 펴주세요.



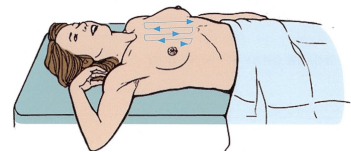
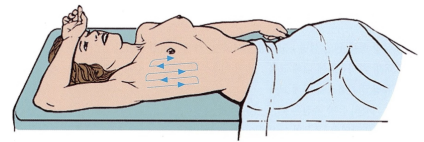
안쪽 진찰하겠습니다.

+) 유두진찰(동의 구하기)

먼저 눌러보겠습니다. (한손 받치고 유두 한바퀴)

분비물 짜보겠습니다. (엄지 검지로 360 도)

이제 반대쪽 하겠습니다.



PPI	옷정리 도와주고 불편한 점 없었는지 확인		
검사, 치료	기본 검사	① 유방촬영술 ② 유방초음파 ③ 혈액검사: CBC, 혈중 PRL, 임신반응검사	
	Cystic lesion	섬유낭 변화 유방낭종 젖낭종	경과관찰, 흡인 흡인, 내부 고형 성분 보이면 중심침생검 흡인
	Solid mass -> 조직검사	섬유선종 엽상종 유방암	경과관찰, 절제 광범위 국소 절제 수술, 항암치료
	Nipple discharge	관내유두종 유방암	유관절제술 유방암 치료

	Inflammation	울혈 -> 유선염 -> 농양	냉/온찜질, 유축/수유 -> 소염제/항생제 -> 농양 시 배액
교육	지금 가장 걱정되는게 있으신가요? 공감/안심) 통증때문에 많이 불편하고 큰병인지 걱정되셨을 것 같습니다. 추정진단) 지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 ~~가 의심됩니다. 기전설명) 가슴 안쪽에 있는 호르몬에 민감한 조직 때문에 생리주기에 따라 통증을 유발할 수 있습니다. 감별진단) 하지만 이 외에도 ~~등의 질환도 배제할 수 없어 추가적인 검사가 필요합니다. 치료) ~~~를 통해 치료할 수 있습니다. 안심) 유방통의 경우 유방암의 직접적인 신호는 아니기에 너무 염려하지 않으셔도 됩니다. 회피/교정) 지방이 많이 함유된 음식 줄이기 술/담배 끊기, 카페인 줄이기, 적절한 운동 엎드려 자지 않기 수유 전 등 유방 만지기 전 손 씻기 자가 검진법 교육) 시기:생리가 끝나고 2~7 일 뒤(가장 말랑할 때). 폐경 후라면 매달 일정한 날짜. 시진:거울 앞에서 양팔을 올리거나 허리에 얹고 피부 함몰, 유두 변화 확인. 촉진:손가락 마디(pads)를 이용해 원을 그리며 겨드랑이까지 꼼꼼히 문지름. 유두를 짜서 분비물이 나오는지 확인. 검사) ① 30 세 이후: 매달 월경 후 3~4 일 쯤 자가검진 ② 35 세 이후: 2 년 간격으로 의사에게 검진 ③ 40 세 이후: 2 년 간격으로 검진과 함께 유방촬영술, 자가검진 선별 검사 유용성) "유방암은 일찍 발견할수록 완치율이 매우 높습니다. 특히 가족력이 있거나 위험 인자가 있는 분들은 자가 검진뿐만 아니라 1~2 년마다 정기적으로 유방 촬영술을 받는 것이 가장 확실한 예방법입니다."		